

Urétroplastie (Réparation de l'urètre)

WARWIKI

Information pour le patient · Chirurgie pour corriger un rétrécissement de l'urètre

L'urétroplastie est une chirurgie pour réparer un rétrécissement de l'urètre — le canal qui évacue l'urine hors du corps. Le rétrécissement (sténose) ralentit ou bloque le jet urinaire ; l'urétroplastie le rétablit et constitue la réparation la plus durable. Cette fiche explique le déroulement, la préparation et ce à quoi vous attendre.

À propos de cette intervention

Un **rétrécissement** est une zone cicatricielle rétrécie de l'urètre qui gêne la vidange de la vessie. Contrairement à la simple dilatation ou incision (souvent récidivantes), l'urétroplastie **reconstruit** l'urètre à un calibre normal — la solution la plus fiable et durable, avec un taux de succès d'environ **85–95 %**. La technique dépend de la localisation et de la longueur du rétrécissement :

- L'**incision** peut être sur le **pénis**, dans la zone entre le scrotum et l'anus (le **périnée**), ou les deux — selon l'emplacement du rétrécissement.
- Un rétrécissement **court** peut être **retiré et les extrémités saines suturées ensemble**.
- Un rétrécissement **plus long** est **élargi à l'aide d'une greffe** — généralement un patch prélevé à l'intérieur de la joue (voir la fiche dédiée).

Votre chirurgien vous indiquera quelle approche convient à votre cas.

Est-ce sans danger ?

L'urétroplastie est une opération bien établie et très efficace ; la plupart des patients gardent un urètre ouvert et fonctionnel. Comme toute chirurgie, elle comporte des risques : saignement, infection ou récurrence du rétrécissement (généralement retraitable). Les effets sur l'érection ou l'éjaculation sont rares et le plus souvent temporaires.

COMPRENDRE LES TERMES

Urètre

Canal qui évacue l'urine hors du corps.

Rétrécissement (sténose)

Zone cicatricielle rétrécie qui ralentit ou bloque le jet urinaire.

Urétroplastie

Chirurgie pour reconstruire l'urètre à un calibre normal.

Greffe

Petit patch de tissu prélevé sur vous-même (souvent à l'intérieur de la joue) pour élargir l'urètre.

Périnée

Zone entre le scrotum et l'anus, où l'une des incisions courantes est réalisée.

Sonde

Tube souple laissé dans l'urètre environ 1 à 4 semaines le temps de la cicatrisation.

Urétrogramme

Radiographie de l'urètre pour vérifier la cicatrisation avant le retrait de la sonde.

Anesthésie générale

Médicament qui vous endort et supprime toute douleur pendant l'opération.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se fait sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien. Ensuite, la zone de l'incision (pénis et/ou périnée) est douloureuse, gonflée et marquée d'ecchymoses pendant quelques semaines — glace, suspensoir et antalgiques aident. Vous aurez une sonde. L'opération dure souvent 2 à 4 heures.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez toutes les consignes pré-opératoires (jeûne, médicaments à suspendre dont les anticoagulants).
- Une **analyse d'urine** vérifie l'absence d'infection — toute infection doit être traitée au préalable.
- **Ne fumez pas** — le tabac ralentit la cicatrisation. Si une greffe de joue est prévue, un bon hygiène bucco-dentaire et un détartrage peuvent être recommandés.
- Prévoyez une **sonde après l'opération (environ 1 à 4 semaines)** et organisez un retour à domicile accompagné.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant**, ou avez une infection urinaire ou cutanée en cours
- Avez eu une chirurgie urétrale, une radiothérapie ou une affection cutanée comme le lichen scléreux

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé à partir de la taille sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Le chirurgien réalise une incision au niveau du rétrécissement (pénis, périnée, ou les deux) et ouvre le segment cicatriciel.
- 3 Le rétrécissement est réparé — retiré et les extrémités suturées, ou élargi par une greffe.
- 4 Une **sonde** est mise en place pour drainer l'urine et protéger la réparation ; les incisions sont refermées.

Après la chirurgie

- Vous rentrez chez vous avec une **sonde**, en général pour **environ 1 à 4 semaines**. Votre équipe vous expliquera comment en prendre soin — ne tirez pas dessus.
- Des **urines légèrement teintées de sang** autour de la sonde sont normales au début.
- **Évitez les efforts, le vélo et les rapports sexuels** pendant plusieurs semaines (souvent ~6) pour permettre la cicatrisation.
- Avant le retrait de la sonde, un **urétrogramme** confirme habituellement la bonne cicatrisation.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- La sonde qui **tombe, se bouche ou cesse de drainer**
- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur ou écoulement croissant au niveau d'une incision
- Un saignement abondant, ou **l'impossibilité d'uriner** après le retrait de la sonde

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'urétroplastie reconstruit un urètre rétréci : la réparation la plus durable. L'incision peut être sur le pénis, le périnée ou les deux, avec parfois une greffe (souvent de la joue).
2. Pour vous préparer : respectez les consignes de jeûne et de médicaments, traitez toute infection au préalable, ne fumez pas, et prévoyez une sonde après l'opération (environ 1 à 4 semaines).
3. Gardez la sonde jusqu'à son retrait par votre équipe (après un urétrogramme de contrôle) et évitez les efforts, le vélo et les rapports sexuels plusieurs semaines.